

Decyzja kliniczna — *nie kara, nie porażka*

Hospitalizacja w AN to narzędzie ratujące życie, nie porażka terapii. Decyzja integruje kryteria medyczne, psychiatryczne i funkcjonalne.

CZAS: 15 min psychoedukacji + decyzja **REALIZACJA:** regularna ocena ryzyka przy AMBER/RED MEED

ŹRÓDŁO: NICE (2017, NG69); AED Medical Care Standards (2021); MEED Royal College of Psychiatrists (2022); APA (2010)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery kategorie kryteriów:** medyczne (bezwzględne), psychiatryczne, funkcjonalne, środowiskowe. W sekcji 02 — **typy hospitalizacji**. Sekcja 03 — **plan:** kiedy decyzja, kto ją podejmuje, jak rozmawiać z pacjentem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Decyzja o hospitalizacji w AN jest *kliniczna*, nie sztywno protokolarna — integruje kryteria medyczne (MEED czerwona strefa), psychiatryczne (ryzyko suicydalne, ciężka depresja) i psychospołeczne (brak wsparcia, niepowodzenie leczenia ambulatoryjnego). NICE NG69 (2017) i AED (2021): hospitalizacja jest *standardem*, nie „opcją” przy zagrożeniu życia. Pacjent z AN z *definicji* ma zaburzoną ocenę własnego stanu (egosyntonia) — decyzja klinicysty waży więcej niż chęć pacjenta, gdy stan zagraża życiu.

01 Cztery kategorie kryteriów — wystarczy *jedno* bezwzględne

KATEGORIA	KRYTERIA
A · Medyczne (bezwzględne)	BMI < 13 (lub < 70% oczekiwanej masy u młodzieży) · bradykardia < 40/min · SBP < 80 mmHg lub ortostazyzm > 20 mmHg · temperatura < 35°C · K+ < 3,0 mmol/l · P < 0,6 mmol/l · arytmie · omdlenia · objawy refeeding syndrome · niewydolność narządowa.
B · Psychiatryczne	Aktywne myśli samobójcze z planem · ciężka depresja · psychoza · ryzyko samookaleczenia nie do opanowania ambulatoryjnie.
C · Funkcjonalne	Brak odpowiedzi na leczenie ambulatoryjne (4–6 tyg. bez postępu) · kolejna utrata wagi mimo leczenia · niemożność pracy/nauki.
D · Środowiskowe	Brak wsparcia (bezdomyłość, przemoc, izolacja totalna) · chaos rodzinny uniemożliwiający leczenie ambulatoryjne.

02 🎯 Typy hospitalizacji — która opcja dla kogo

SPECJALISTYCZNY ED

Najlepsza opcja. Oddział z doświadczonym zespołem, znajomością *refeedingu*, psychoterapią w trakcie pobytu. Ograniczona dostępność w Polsce.

INTERNISTYCZNY / PEDIATRYCZNY

Priorytet medyczny. Gdy stan czerwony MEED (BMI < 13, arytmie) i oddział ED niedostępny. Psychoterapia ograniczona.

PHP / IOP

Pośrednie. Kilka godzin dziennie, posiłki nadzorowane, terapia grupowa i indywidualna, bez nocnego pobytu. Dla pacjentów stabilnych medycznie.

03 ✎ Plan hospitalizacji — kiedy, kto, jak

KTÓRE KRYTERIA U MNIE/BLISKIEJ OSOBY SĄ OBECNE

— medyczne / psychiatryczne / funkcjonalne / środowiskowe;
jakie konkretnie

KTO DECYDUJE

— psychiatra prowadzący; w stanie zagrożenia także lekarz
SOR; konsultacja z zespołem ambulatoryjnym

CO CHCĘ WIEDZIEĆ PRZED PRZYJĘCIEM

— protokół oddziału, godziny odwiedzin, *refeeding*, długość
typowego pobytu

MÓJ PLAN PO WYPISIE

— kontynuacja terapii, kontrole medyczne, zapobieganie
nawrotom; planowanie w trakcie pobytu

Klucz: hospitalizacja w AN to *narzędzie ratujące życie*, nie kara. Wystarczy *jedno* kryterium bezwzględne — nie czeka się na „spełnienie wszystkich”. Regularnie oceniam ryzyko co 1-2 tyg. przy AMBER/RED MEED. Pacjent z silną ambiwalencją może odmawiać — w sytuacji zagrożenia życia decyzja klinicysty jest nadrzędna. W Polsce: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (art. 23 — przyjęcie nagłe, art. 24 — wniosek do sądu) reguluje przyjęcia bez zgody. Komunikat: „*zdrowie twojego ciała wymaga monitorowania, którego ambulatoryjnie nie da się zapewnić*”.

△ Hospitalizacja nie jest „zamiast” terapii — jest fragmentem dłuższego leczenia. Plan po wypisie powinien być rozpoczęty w trakcie pobytu szpitalnego.